

Orkiestra *bez dyrygenta*

Instrumenty grają (umiejętności są), ale nikt nie koordynuje. ADHD to nie deficyt uwagi — to zaburzenie systemu zarządzania.

CZAS: 15 min czytania Psychoedukacja po Barkleyu **ŹRÓDŁO:** Brown (2005, 2013); Brown ADD Scales

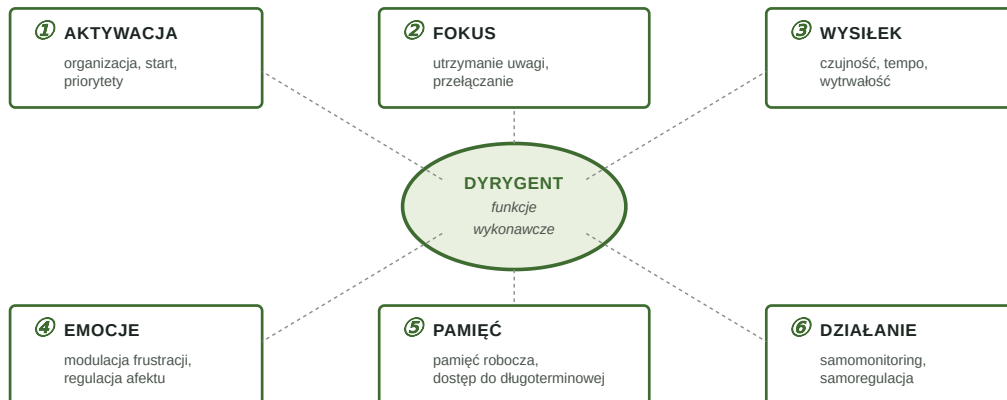
JAK UŻYWAĆ

Naucz się rozpoznawać **sześć klastrow funkcji wykonawczych** w modelu Thomasa Browna. Zidentyfikuj, w których **swich** klastrach widzisz największe trudności. To precyzyjniejsze niż „mam ADHD” — pozwala *kierunkować* strategię i ocenić, co działa.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model Thomasa Browna (2005, 2013) to **drugi najbardziej wpływowy** model ADHD po Barkleyu — uzupełnia go o perspektywę *funkcji wykonawczych jako systemu*. Brown porównuje mózg ADHD do **orkiestry bez dyrygenta**: instrumenty (umiejętności) są sprawne, ale nie ma kogoś, kto je koordynuje. ADHD *nie jest* zaburzeniem uwagi — jest **zaburzeniem koordynacji** sześciu wzajemnie powiązanych funkcji wykonawczych. Model leży u podstaw narzędzia diagnostycznego *Brown ADD Scales* i jest **szczególnie pomocny dla kobiet** z ADHD typu nieuwagowego, u których dominują problemy z aktywacją, wysiłkiem i pamięcią — nie hiperaktywnością.

01 {} Sześć klastrow Browna



Klucz Browna: ADHD *nie jest* brakiem uwagi. Jest **zaburzeniem koordynacji** wszystkich sześciu klastrow. Każdy z osobna może działać poprawnie w krótkim oknie — ale ich *jednoczesne uruchomienie i utrzymanie* jest tym, co zawodzi.

02 ? Każdy klaster — co konkretnie szwankuje

① AKTYWACJA

„Wiem, co mam zrobić, ale **nie mogę zacząć**".
Trudność z priorytetyzacją, planowaniem,
rozpoczęciem.

② FOKUS

„**Uciekam uwagą** co kilka minut". Trudność z
utrzymaniem skupienia, łatwe rozproszenie, problem
z przełączaniem między zadaniami.

③ WYSIŁEK

„Sił mam, dopóki ciekawe — **nudne mnie
wykańcza**". Trudność z regulacją czujności i tempa,
zmęczenie umysłowe.

④ EMOCJE

„**Reaguję mocniej** niż chciałbym/-abym". Trudność z
modulacją frustracji, gniew/smutek z drobiazgów,
długie powracanie do równowagi.

⑤ PAMIĘĆ

„Wszedłem/-am do kuchni i **nie wiem po co**".
Trudność z pamięcią roboczą, gubienie wątku, słaby
dostęp do faktów, które „wiem”.

⑥ DZIAŁANIE

„**Robię, zanim pomyślę**". Trudność z
samomonitorowaniem, regulacją tempa działania,
hamowaniem impulsu.

03 ✎ Twoja mapa klastrów — gdzie najsilniej

Oceń każdy klaster od 1 (lekka trudność) do 10 (poważna trudność). Klastry 7+ to priorytety pracy klinicznej.

① Aktywacja	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	② Fokus	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
③ Wysiłek	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	④ Emocje	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
⑤ Pamięć	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	⑥ Działanie	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Klucz: Model Browna jest *szczególnie cenny* dla osób, które nie pasują do klasycznego obrazu „hiperaktywnego chłopca” — kobiet z typem nieuwagowym, dorosłych z subtelnymi objawami, osób z wysokim IQ kompensujących wysiłkiem. Brown (2013): „*klasyczne kryteria DSM uchwytują 60–70% przypadków ADHD u dorosłych; model funkcji wykonawczych — 90%+*”. Identyfikacja **swoich** najsilniejszych klastrów pozwala precyzyjnie wybrać strategie kompensacyjne. Aktywacja → eksternalizacja + mikro-kroki. Fokus → blokery + pomodoro. Emocje → DBT + RSD. Pamięć → eksternalizacja + GTD. Itd.